EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

Educador/a Social | BOP Sevilla nº 102 (29/05/2026) | Tema 56 - Específico

Tema 56 — Programación y planificación en el acogimiento residencial. Programación de la vida cotidiana. Concepto de calidad en el ámbito educativo. Instrumentos generales para la acción educativa. La evaluación del menor. Evaluación del programa de acogimiento residencial.

Convocatoria: Subescala Técnica - Educador/a Social (Grupo A2). Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

Oferta de Empleo Público Consolidada: Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla nº 102, de 29/05/2026.

Especialidad: Intervención Socioeducativa en Infancia, Familia y Acogimiento Residencial.

1. Introducción y Justificación Epistemológica y Legal

El acogimiento residencial de personas menores de edad constituye una de las medidas de protección de mayor intensidad socioeducativa y jurídica del ordenamiento jurídico español. Lejos de la concepción custodial, asilar o meramente asistencial que caracterizó históricamente a los internados e inclusas benéficas, la pedagogía social y el derecho contemporáneo conciben el acogimiento residencial como un **recurso de protección temporal, especializado, altamente tecnificado y orientado a la restitución de derechos y a la normalización comunitaria**.

En el sistema público de servicios sociales y protección de menores, la programación y planificación no son meros requisitos burocráticos, sino la garantía técnico-pedagógica de que cada decisión cotidiana responda a una intencionalidad transformadora y al interés superior del menor, superando cualquier atisbo de improvisación o arbitrariedad institucional.

Marco Normativo Estatal y Autonómico

El régimen del acogimiento residencial descansa sobre una jerarquía normativa articulada en el plano internacional, estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

```
                JERARQUÍA NORMATIVA EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ NIVEL INTERNACIONAL:                                                 │
│ · Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989): Arts. 3, 9, 12, 20 y │
│   25 (revisión periódica preceptiva del internamiento de protección).│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ NIVEL ESTATAL:                                                       │
│ · Ley Orgánica 1/1996 (LOPJM) tras reforma de la Ley 26/2015:        │
│   - Art. 21 bis: Principios de subsidiariedad y excepcionalidad del  │
│     acogimiento residencial respecto al familiar.                    │
│   - Prohibición absoluta de acogimiento residencial para menores de 3 años │
│     salvo imposibilidad debidamente acreditada o razones de salud.   │
│   - Preferencia imperativa de acogimiento familiar para menores de 6 años. │
│   - Art. 22 ter: Programas de preparación para la vida independiente a │
│     partir de los 16 años.                                           │
│ · Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI): Protección integral de la infancia contra la │
│   violencia; figura obligatoria del Coordinador/a de Protección en centros; │
│   prohibición tajante de castigos corporales o humillantes.          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ NIVEL AUTONÓMICO ANDALUZ:                                            │
│ · Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía: │
│   - Consagración del derecho a ser escuchado y participar en su plan. │
│   - Prioridad de la reintegración en la familia biológica.           │
│ · Decreto 355/2003, de 16 de diciembre: Acogimiento residencial en centros │
│   de protección de personas menores de edad en Andalucía.            │
│ · Orden de 11 de febrero de 2004: Normas de funcionamiento, ratios,  │
│   espacios y condiciones materiales de los centros de menores en Andalucía. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

La premisa legal y axiológica indiscutible es el **principio de subsidiariedad y excepcionalidad**: el acogimiento residencial solo procede cuando el acogimiento familiar (en familia extensa o ajena) resulte inviable, desaconsejado o contrario al interés superior de la persona menor, debiendo mantenerse durante el tiempo estrictamente indispensable para lograr la reunificación con la familia de origen o la formalización de una medida estable alternativa.

2. Programación y Planificación en el Acogimiento Residencial

2.1. De la Institución Total a la Residencia Educativa Normalizada

La evolución histórica del acogimiento institucional experimentó un giro copernicano gracias a las aportaciones de la sociología y la pedagogía social crítica. Las advertencias de **Erving Goffman (1961)** sobre los efectos devastadores de las "instituciones totales" —ruptura de barreras entre esferas vitales, descualificación personal, cronificación de la dependencia, despersonalización y mortificación del yo— impulsaron en España, a partir de la Ley 21/1987 y la Ley Orgánica 1/1996, un proceso radical de desinstitucionalización.

Los antiguos macrocentros masificados fueron sustituidos por **hogares y residencias de pequeña dimensión comunitaria** (generalmente de 8 a 10 plazas, con un máximo de 12 a 16 según tipología y conforme a los estándares de la Sociedad Española para el Estudio del Acogimiento Residencial, SECAR), insertos en barrios normalizados, cercanos a colegios ordinarios, centros de salud y recursos de ocio vecinales.

La planificación en este contexto moderno se define como el proceso técnico mediante el cual el equipo educativo diseña, anticipa, implementa y evalúa de forma sistemática y coherente los fines, métodos y recursos necesarios para transformar la estancia del menor en una experiencia de reparación vincular, aprendizaje normativo y desarrollo integral.

2.2. Niveles de Planificación y Jerarquía Documental del Centro de Protección

La planificación en los centros de protección de menores en Andalucía se vertebra en una estructura piramidal que va desde la dimensión institucional global hasta la programación estrictamente personalizada:

```
                JERARQUÍA DOCUMENTAL DEL CENTRO RESIDENCIAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ NIVEL MACRO-ESTRATÉGICO (Documentos de Centro):                          │
│ 1. Proyecto Educativo de Centro (PEC)                                    │
│    · Marco conceptual, señas de identidad, modelo pedagógico, teoría vincular.│
│ 2. Reglamento de Régimen Interior (RRI) / Normas de Funcionamiento       │
│    · Orden de 11/02/2004: Convivencia, derechos/deberes, límites y normas.│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ NIVEL MESO-OPERATIVO (Planificación Anual):                              │
│ 3. Programación Anual de Centro (PAC)                                    │
│    · Cronograma operativo de actividades, formación, mejoras y presupuesto.│
│ 4. Memoria Anual de Gestión y Evaluación                                 │
│    · Balance técnico, indicadores de logro y plan de mejora continua (PDCA).│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ NIVEL MICRO-INDIVIDUAL (Intervención con el Menor):                      │
│ 5. Proyecto Educativo Individualizado (PEI)                              │
│    · Decreto 355/2003: Diagnóstico, objetivos SMART, áreas y revisión semestral.│
│ 6. Plan de Preparación para la Vida Independiente (a partir de los 16 años).│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. Proyecto Educativo de Centro (PEC):

- Es el documento institucional de mayor rango del centro. Define las señas de identidad, los valores pedagógicos, la fundamentación teórica (teoría del apego de John Bowlby, enfoque de resiliencia de Boris Cyrulnik, modelo ecológico-sistémico de Urie Bronfenbrenner), los objetivos generales del acogimiento y las líneas metodológicas comunes que deben presidir la convivencia.

2. Reglamento de Régimen Interior / Normas de Funcionamiento:

- Conforme a la **Orden de 11 de febrero de 2004**, regula las normas de convivencia democrática, la distribución de tareas domésticas, el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el régimen de salidas, permisos y visitas familiares, y el catálogo de medidas de corrección pedagógica ante faltas a la convivencia, con proscripción absoluta de sanciones humillantes, privación de alimentos o merma de la escolarización.

3. Programación Anual de Centro (PAC):

- Planifica de forma temporalizada para cada ejercicio las actividades colectivas (talleres, salidas culturales, campamentos de verano), la formación continua del equipo educativo, las mejoras materiales de la vivienda y el cronograma de revisiones técnicas interdisciplinares.

4. Memoria Anual:

- Documento evaluativo de cierre de ejercicio donde se analizan los indicadores de ocupación, los resultados de los PEI, las coordinaciones con los servicios sociales comunitarios y los centros educativos, y las áreas de mejora para la PAC del ejercicio siguiente.

3. Programación de la Vida Cotidiana

3.1. La Vida Cotidiana como Escenario y Herramienta Pedagógica

En la Pedagogía Social contemporánea, la **vida cotidiana** no es el mero telón de fondo donde ocurren los acontecimientos; es la **herramienta metodológica nuclear de la intervención socioeducativa** (**Jaume Funes, 1996; Antoni Petrus, 1997; Jesús Palacios, 2003**). Los menores que ingresan en un centro de protección proceden casi invariablemente de entornos caóticos, negligentes o violentos, marcados por la ausencia de rutinas predecibles, la inversión de roles parentales y la vivencia de traumas relacionales tempranos.

La vida cotidiana estructurada, cálida y predecible cumple tres funciones terapéuticas y pedagógicas esenciales:

- **Función Reorganizadora y Estructurante**: La existencia de ritmos estables y secuencias temporales regulares proporciona seguridad ontológica al menor, disminuyendo la angustia y la necesidad de control hipervigilante propia de los traumas tempranos (**Bessel van der Kolk, 2014**).
- **Función Socializadora y de Aprendizaje Normativo**: A través de los actos ordinarios (poner la mesa, recoger su habitación, respetar turnos de palabra en la cena) se interiorizan de manera natural pautas de convivencia democrática y autorregulación.
- **Función Vinculante y Reparadora del Apego**: El cuidado continuo y sincrónico en los momentos ordinarios (preparar el desayuno, curar una herida, acompañar al médico, arropar por la noche) permite la construcción de vínculos de **apego secundario seguro** con las figuras educativas de referencia (**Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan, 2005**).

```
                    ESTRUCTURACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RITMOS TEMPORALES ESTABLES:                                          │
│ · Despertar acogedor y aseo personal matutino.                       │
│ · Desayuno compartido y salida puntual al centro escolar ordinario.  │
│ · Almuerzo en familia residencial y tiempo de distensión comunicativa.│
│ · Estudio guiado y apoyo escolar supervisado por el Educador/a Social.│
│ · Actividades extraescolares en la comunidad (deporte, arte, talleres).│
│ · Tareas de intendencia y corresponsabilidad doméstica según edad.   │
│ · Cena comunitaria y ASAMBLEA RESIDENCIAL SEMANAL.                   │
│ · Rutina de desaceleración, higiene nocturna y descanso predecible.  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ DIMENSIONES DEL ESPACIO FÍSICO:                                      │
│ · Espacios Comunes Acogedores: Sala de estar, comedor familiar, biblioteca.│
│ · Espacio Privado e Intimidad: Habitaciones individuales o compartidas (máx.│
│   2 menores) con personalización libre (fotos, pósteres, objetos propios).│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ LA FIGURA DEL EDUCADOR/A TUTOR/A DE REFERENCIA:                      │
│ · Profesional asignado a cada menor para liderar su PEI, coordinar su Libro│
│   de Vida, mantener las entrevistas tutoriales y contactar con la familia.│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.2. Clima Relacional y la Asamblea de Centro

El clima relacional en el centro residencial debe evitar el autoritarismo represivo y la permisividad negligente, posicionándose en un modelo de **autoridad democrática y calidez afectiva**:

- **La Asamblea de Menores y Educadores**: Es el órgano de participación directa y vida comunitaria del hogar residencial, celebrada con periodicidad semanal. En ella se debaten los conflictos convivenciales, se consensúan propuestas de ocio, se planifican los menús y las salidas de fin de semana, y se revisa el cumplimiento de las tareas de convivencia. Este órgano materializa de forma tangible el derecho a la participación y a la libre expresión garantizado en el artículo 12 de la CDN y el artículo 9 de la LOPJM.

3.3. Manejo Educativo del Conflicto, Desescalada y Enfoque del Trauma

Los menores tutelados presentan con frecuencia conductas externalizantes (agresividad verbal, desafío normativo, rotura de objetos) que representan mecanismos de defensa adaptativos frente al dolor psíquico del abandono o maltrato. El equipo de educadores sociales debe operar bajo el paradigma de la **atención sensible al trauma** (Bruce Perry, 2006):

1. Comprensión Neurobiológica: La conducta disruptiva es leída como una respuesta de hiperactivación del sistema límbico (lucha o huida) y desregulación emocional, no como maldad o desafío personal.

2. Ciclo de Crisis y Fases de Desescalada:

- *Fase de Activación*: Identificación precoz de desencadenantes (visitas familiares frustradas, estrés académico) y reducción de estímulos estresores.

- *Fase de Escalada*: Contención verbal empática, tono de voz pausado, lenguaje corporal abierto, evitación de confrontaciones de poder o ultimátums.
- *Fase de Crisis*: Seguridad física y contención emocional. Aplicación estricta de la **LOPIVI**: queda categóricamente prohibida cualquier medida de fuerza desproporcionada, sujeción mecánica lesiva o aislamiento en celdas. Se aplica el acompañamiento presencial en un entorno de seguridad (*time-in* o espacio de calma acompañado, en lugar del *time-out* expulsivo).
- *Fase de Desescalada y Reconciliación*: Cuando se recupera la corteza prefrontal (calma neurofisiológica), el Educador/a Social realiza una entrevista reflexiva para ayudar al menor a nombrar su emoción, analizar las consecuencias y pactar una reparación pedagógica restaurativa.

3.4. Preparación para la Vida Independiente y Emancipación

El artículo 22 ter de la LOPJM y la Ley 4/2021 de Andalucía imponen el deber de iniciar programas específicos de preparación para la vida independiente a partir de los **16 años**:

- **Competencias de Autonomía Instrumental**: Cocina, compra responsable, gestión del presupuesto personal, mantenimiento del hogar, gestiones administrativas (empadronamiento, tarjeta sanitaria, DNI, trámites telemáticos).
- **Itinerarios de Cualificación Profesional**: Orientación vocacional, matriculación en Formación Profesional básica o de grado medio, programas de segunda oportunidad y empleo juvenil.
- **Transición y Mayoría de Edad**: Derivación coordinada y acompañamiento hacia los recursos del **Programa de Mayoría de Edad de la Junta de Andalucía** (pisos tutelados de autonomía, becas de emancipación, seguimiento socioeducativo extendido hasta los 21 o 25 años si cursan estudios superiores).

---

4. Concepto de Calidad en el Ámbito Educativo y Residencial

4.1. De la Calidad Asistencial a la Calidad de Vida

El concepto de calidad en el acogimiento residencial ha experimentado un profundo salto cualitativo en las tres últimas décadas:

- **Modelo Asistencial Tradicional (Años 70-80)**: Centrado exclusivamente en la calidad de la estructura y la hostelería: condiciones higiénico-sanitarias, cumplimiento de ratios de metros cuadrados y camas por habitación, seguridad de las instalaciones y suficiencia calórica de la alimentación.
- **Modelo de Calidad de Vida (Robert Schalock y Miguel Ángel Verdugo, 2002)**: La calidad de un centro residencial se evalúa por su capacidad de generar un impacto positivo demostrable en el bienestar integral del menor a lo largo de las **ocho dimensiones universales de calidad de vida**:

```
                LAS 8 DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA EN EL ACOGIMIENTO

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. BIENESTAR EMOCIONAL: Seguridad percibida, apego, autoestima, reducción
   del estrés y vivencia de estabilidad emocional.
│ 2. RELACIONES INTERPERSONALES: Amistades normalizadas, red de apoyo en el
   centro y en la comunidad, mantenimiento del lazo con familia biológica.
│ 3. BIENESTAR MATERIAL: Ropa digna y elegida por el menor, espacio íntimo,
   disponibilidad de dinero de bolsillo (paga semanal educativa).
│ 4. DESARROLLO PERSONAL: Rendimiento escolar, adquisición de habilidades de
   autonomía de la vida diaria, madurez cognitiva y moral.
│ 5. BIENESTAR FÍSICO: Salud integral, nutrición balanceada, chequeos médicos,
   salud bucodental y fomento del deporte federado o de barrio.
│ 6. AUTODETERMINACIÓN: Capacidad de elección, establecimiento de metas
   propias, participación activa en las decisiones de su propio PEI.
│ 7. INCLUSIÓN SOCIAL: Uso de recursos comunitarios ordinarios (bibliotecas,
   polideportivos, centros cívicos) sin estigma de centro de menores.
│ 8. DERECHOS: Privacidad, intimidad personal, confidencialidad del expediente
   y garantías procesales de escucha activa (art. 9 LOPJM).
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.2. Estándares de Calidad en Acogimiento Residencial

En el marco estatal, la Sociedad Española para el Estudio del Acogimiento Residencial (**SECAR**) y los trabajos de **Amaia Bravo y Jorge F. Del Valle (2009)** han establecido estándares de calidad técnica que vertebran las buenas prácticas residenciales:

- **Profesionalización y Estabilidad del Equipo**: Cobertura prioritaria por profesionales con titulación de Grado o Diplomatura en Educación Social. Minimización de la rotación de plantilla para garantizar continuidad vincular y

evitar revictimizaciones por pérdidas afectivas secundarias.

- **Ratio Educador/Menor y Supervisión**: Mantenimiento de ratios que garanticen la supervisión activa diurna y nocturna conforme al Decreto 355/2003 y la Orden de 11 de febrero de 2004.
- **Intervención Basada en la Evidencia**: Utilización de instrumentos estandarizados para la evaluación y seguimiento conductual y emocional de los menores acogidos.
- **Promoción Activa del Retorno Familiar**: El centro no compite con la familia de origen, sino que actúa como recurso de apoyo transitorio mientras se corrigen las situaciones de desamparo en el hogar familiar.

---

5. Instrumentos Generales para la Acción Educativa

La praxis pedagógica del Educador/a Social en el centro residencial requiere el manejo sistemático de herramientas técnico-pedagógicas protocolizadas:

```
                    INSTRUMENTOS DE LA ACCIÓN EDUCATIVA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. EL PROYECTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO (PEI):                      │
│    · Documento nuclear individual. Diagnóstico, metas SMART, estrategias y
│      revisión semestral preceptiva (Decreto 355/2003).               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. EL LIBRO DE VIDA (Life Story Book):                               │
│    · Reconstrucción terapéutica de la historia e identidad del menor (fotos,
│      árbol genealógico, recuerdos, certificados escolares).          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. EL CUADERNO DE RELEVO Y LIBRO DE INCIDENCIAS:                     │
│    · Registro diario y cronológico para garantizar la continuidad    │
│      interdisciplinar entre turnos de educadores.                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. CONTRATOS CONDUCTUALES Y ACUERDOS SOCIOEDUCATIVOS:                │
│    · Pactos formales negociados para la autorregulación y motivación.│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. LA ENTREVISTA TUTORIAL PERIÓDICA:                                 │
│    · Espacio confidencial y sistemático entre el menor y su educador tutor.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN LOPIVI (LO 8/2021):          │
│    · Prevención del acoso, abusos sexuales, conductas autolíticas y TIC.
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.1. El Proyecto Educativo Individualizado (PEI)

El PEI es el instrumento de máxima jerarquía operativa en la intervención directa con cada menor. Regulado por el **Decreto 355/2003** y la **Ley 4/2021 de Andalucía**:

- **Plazo de Elaboración**: Se formula de manera obligatoria durante la fase de acogida y observación diagnóstica inicial, en un plazo no superior a **30 a 45 días** desde el ingreso formal del menor.
- **Contenido y Estructura Técnica**:

1. *Datos Biográficos y Administrativos*: Datos filiales, resolución administrativa de desamparo, fechas de ingreso, asignación del educador/a tutor/a de referencia.

2. *Diagnóstico Inicial Multidimensional*: Valoración exhaustiva de necesidades y potencialidades en salud, educación, afectividad, habilidades sociales y dinámica familiar.

3. *Objetivos Operativos por Áreas de Desarrollo*: Redactados bajo criterios SMART (específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalizados):

- *Área de Salud y Autocuidado*: Hábitos higiénicos, adherencia a tratamientos médicos, nutrición y descanso.
- *Área Escolar-Formativa*: Escolarización efectiva, regularidad en la asistencia, técnicas de estudio y refuerzo en materias suspensas.
- *Área Personal y Afectiva*: Autoestima, gestión de la frustración, expresión de emociones y tramitación de vivencias traumáticas.
- *Área Social y Convivencial*: Integración en el grupo de iguales del centro, respeto a las normas, participación en actividades comunitarias.
- *Área Familiar*: Frecuencia y calidad de los contactos, visitas supervisadas o no supervisadas, trabajo conjunto con los servicios sociales comunitarios para la reunificación.

4. *Metodología y Actividades*: Estrategias de modelado, refuerzo diferencial, acuerdos conductuales y entrevistas de tutoría.

5. *Indicadores de Evaluación*: Criterios objetivos y verificables para medir el grado de consecución de cada objetivo.

- **Revisión Preceptiva**: Conforme a la legislación estatal y autonómica, el PEI debe ser objeto de **revisión y actualización formal cada seis meses (semestralmente)**, o antes si acontecen cambios sustanciales en la situación del menor, remitiendo copia formal al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial y a la Fiscalía de Menores.

5.2. El Libro de Vida (*Life Story Book*)

Conceptualizado internacionalmente por **Vera Fahlberg (1991)** en el marco de la psicología del apego y el acogimiento:

- **Concepto y Finalidad**: Es un álbum o libro narrativo estructurado que el menor elabora de forma guiada y voluntaria con la mediación de su educador/a tutor/a de referencia.
- **Misión Terapéutica**: Los menores que sufren rupturas familiares y cambios residenciales experimentan frecuentes "lagunas de memoria", sentimientos de culpa ("mis padres me abandonaron por ser malo") y una identidad fragmentada. El Libro de Vida recopila fotografías de su infancia, partidas de nacimiento, cartas de familiares, recuerdos significativos, diplomas escolares y relatos veraces y desculpabilizadores sobre su trayectoria vital.
- **Efecto Pedagógico**: Permite al menor dotar de sentido a su biografía, reconciliarse con su pasado y proyectar su futuro personal. Es propiedad exclusiva e inalienable del menor, acompañándolo al abandonar el centro.

5.3. El Cuaderno de Relevo y el Libro de Incidencias Diarias

- **Función Técnico-Deontológica**: Instrumento diario donde los educadores de cada turno (mañana, tarde, noche) consignan cronológicamente las informaciones relevantes de la convivencia: administración de fármacos prescritos, asistencia al centro escolar, incidencias conductuales, visitas familiares recibidas, salidas autorizadas y clima general del hogar.
- **Rigor Documental**: Debe redactarse con lenguaje descriptivo, objetivo y no estigmatizante, sin apreciaciones subjetivas o juicios morales, constituyendo un registro auditable de garantía jurídica y continuidad asistencial.

5.4. Contratos Conductuales y Acuerdos Socioeducativos

- **Mecanismo de Autorregulación**: Acuerdos escritos negociados entre el menor y el equipo educativo. Definen con precisión conductas-meta deseadas, refuerzos contingentes positivos y consecuencias lógicas pactadas ante el incumplimiento, fomentando la responsabilidad personal frente a la imposición externa.

5.5. Fichas de Seguimiento de Salud, Escolaridad y Red Social

- Registros sistemáticos de citas médicas, vacunación, revisiones bucodentales, coordinación con Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ), seguimiento quincenal de notas y asistencias escolares, y directorio seguro de la red familiar y social autorizada.

5.6. Protocolos Específicos de Protección conforme a la LOPIVI (LO 8/2021)

En cumplimiento imperativo de la **Ley Orgánica 8/2021**:

- **Coordinador/a de Protección del Centro**: Figura técnica designada para velar por los protocolos de buen trato, canalizar quejas y notificar incidencias a las autoridades judiciales y administrativas.
- **Protocolos de Actuación Preceptivos**:

1. *Protocolo ante Sospecha o Revelación de Abuso Sexual Infantil (ASI).*
2. *Protocolo de Prevención e Intervención en Acoso y Ciberacoso escolar/residencial.*
3. *Protocolo de Detección y Abordaje de Conductas Autolíticas e Ideación Suicida.*
4. *Protocolo de Salidas no Autorizadas (Fugas).*

---

6. La Evaluación del Menor en el Acogimiento Residencial

La evaluación del menor en acogimiento residencial no es una fiscalización punitiva ni un diagnóstico patologizante; es un **proceso continuo, sistemático, multidimensional y participativo** orientado a orientar la intervención pedagógica y fundamentar las decisiones jurídicas sobre la medida de protección.

```
                    FASES DE LA EVALUACIÓN DEL MENOR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. EVALUACIÓN INICIAL O DIAGNÓSTICA (Primeros 30-45 días):               │
│    · Salud física, historia escolar, desarrollo afectivo, vínculos de apego, │
│      detección de traumas, anamnesis psicosocial. Base del primer PEI.   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. EVALUACIÓN PROCESUAL O FORMATIVA (Semanal y mensual):                 │
│    · Análisis en reunión de equipo, monitorización de objetivos cotidianos, │
│      adaptación de estrategias metodológicas, registro de incidencias.   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. EVALUACIÓN SEMESTRAL PRECEPTIVA (Cada 6 meses):                       │
│    · Informe formal de seguimiento al Servicio de Protección de Menores y a │
│      la Fiscalía. Valoración de progresos, adecuación de la medida.      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. EVALUACIÓN FINAL O DE EGRESO:                                         │
│    · Balance de logros ante reunificación familiar, acogimiento familiar o │
│      transición a la mayoría de edad y vida independiente.               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6.1. Áreas Clave e Indicadores de Evaluación del Menor

La evaluación del menor se desglosa en cinco áreas operativas fundamentales:

Área Evaluativa	Dimensiones e Indicadores Analizados	Técnicas e Instrumentos Utilizados
Salud y Desarrollo Físico	Crecimiento ponderal, salud bucodental, vacunación, higiene personal, hábitos de sueño, patrones alimentarios, consumo de sustancias.	Revisiones pediátricas, registro de hábitos, coordinación con Centro de Salud.
Desarrollo Cognitivo y Escolar	Competencia curricular, asistencia escolar, rendimiento académico, motivación de logro, habilidades de estudio, integración con compañeros de clase.	Calificaciones escolares, informes tutoriales del colegio/IES, entrevistas con el EMAE.
Desarrollo Emocional y Apego	Autoestima, autorregulación de impulsos, gestión de la frustración, estilo de apego, sintomatología ansiosa/depresiva, elaboración del duelo por separación.	BASC-3, SENA, Escala de Autoestima de Rosenberg, observación clínica del equipo.
Competencia Social y Convivencial	Habilidades de comunicación asertiva, resolución pacífica de conflictos, empatía, respeto a normas residenciales, integración en ocio comunitario.	Registros de observación, sociogramas, Escala de Habilidades Sociales (Gismero).
Dinámica y Vínculos Familiares	Actitud ante las visitas, vivencia afectiva tras los contactos familiares, calidad del vínculo parental, nivel de cumplimiento de compromisos por los padres.	Registros de visitas de contacto, entrevistas con el ETF municipal, libro de visitas.

6.2. Instrumentos Estandarizados y Baterías de Valoración

El Educador/a Social y el equipo técnico recurren a instrumentos psicopedagógicos de acreditada validez psicométrica:

- **SENA (Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes, Fernández-Pinto et al., 2015)**: Evalúa problemas externalizantes, internalizantes, contextuales y recursos personales.
- **BASC-3 (Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes, Reynolds y Kamphaus)**: Escala multidimensional para padres, tutores/educadores y autoinforme del menor.
- **AF-5 (Autoconcepto Forma 5, García y Musitu)**: Mide el autoconcepto en sus dimensiones académica, social, emocional, familiar y física.
- **CBCL (Child Behavior Checklist de Achenbach)**: Cribado de problemas conductuales y afectivos en contextos residenciales.

6.3. La Participación del Menor en su Propia Evaluación

En cumplimiento del artículo 12 de la CDN, el artículo 9 de la LOPJM y la Ley 4/2021 de Andalucía:

- La evaluación debe incorporar de forma activa la **voz de la persona menor de edad**.
- Mediante entrevistas tutoriales reflexivas y rúbricas de autoevaluación adaptadas a su nivel madurativo, el menor analiza sus propios avances, expresa qué metas del PEI le resultan difíciles o desmotivadoras, y propone ajustes en su plan formativo, transformándose de objeto pasivo de intervención en **sujeto protagonista de su proceso educativo**.

---

7. Evaluación del Programa de Acogimiento Residencial

La evaluación de los programas de acogimiento residencial trasciende la evolución singular del menor para auditar la eficacia, eficiencia, equidad y calidad global de la institución. Siguiendo el modelo sistémico universal de **Avedis Donabedian (1980)** adaptado al ámbito socioeducativo por **Bravo y Del Valle (2009)**, la evaluación institucional se estructura en tres niveles interconectados:

```
MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE DONABEDIAN
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA (Condiciones y Recursos):         │
│    · Calidad física del inmueble (habitaciones, zonas comunes, luz, calor).
│    · Ratios educador/menor diurnas y nocturnas (Orden de 11/02/2004).
│    · Cualificación profesional (titulaciones oficiales en Educación Social).
│    · Estabilidad de la plantilla y tasa de rotación laboral.     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. EVALUACIÓN DEL PROCESO (Dinámicas y Metodología):             │
│    · Grado de rigor técnico en el diseño y cumplimiento de los PEI.
│    · Clima social y convivencia residencial (Escala CIES de Moos).
│    · Frecuencia y calidad de las coordinaciones escolares y con el ETF.
│    · Eficacia de los protocolos LOPIVI y mecanismos de escucha al menor.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS / IMPACTO (Efectos a Medio y Largo Plazo):
│    · Tasa de reunificación familiar exitosa y sostenible (sin reingreso).
│    · Porcentaje de éxito escolar y promoción a estudios post-obligatorios.
│    · Grado de inserción sociolaboral en jóvenes mayores de 18 años.
│    · Bienestar subjetivo y satisfacción evaluada por menores y familias.
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.1. Dimensiones e Indicadores Técnicos de Calidad

Nivel de Evaluación	Dimensiones e Indicadores Analizados	Instrumentos Técnicos de Medición
Estructura	Cumplimiento estricto de ratios técnicas; adecuación de instalaciones; plan de formación continua de la plantilla; presupuesto por menor/día.	Auditorías de la Inspección de Servicios Sociales, actas de personal, balances de gestión.
Proceso	Metodología de vida cotidiana; rigor en el PEI; coordinación con Servicios Sociales Comunitarios de Utrera y colegios locales; gestión de crisis no lesiva.	Escala CIES (Clima Social en Instituciones), actas de equipo técnico, libro de relevos.
Resultados	Porcentaje de metas conseguidas en los PEI; tasa de retornos familiares estables; índice de conductas delictivas o fugas; inserción sociolaboral a los 18 años.	Indicadores cuantitativos del cuadro de mando, encuestas de calidad percibida, memorias de egreso.

7.2. Encuestas de Satisfacción y Participación de Familias y Menores

Un sistema moderno de calidad exige recopilar sistemáticamente la percepción de los usuarios del servicio:

- **Cuestionario de Satisfacción de Menores Acogidos**: Formulario anónimo y adaptado a la edad donde los menores valoran la calidad de la comida, el trato recibido de los educadores, el respeto a su intimidad, las actividades de ocio y su preparación para el futuro.
- **Cuestionario para Familias Biológicas**: Recoge el grado en que los padres se han sentido informados, respetados y apoyados por el equipo educativo en el régimen de visitas y en el trabajo hacia la reunificación.

7.3. La Memoria Anual y el Ciclo de Mejora Continua (Ciclo PDCA)

Los resultados de la evaluación del programa no se archivan pasivamente; alimentan el **Ciclo de Deming (PDCA: Planificar - Hacer - Verificar - Actuar)**:

1. *Planificar (Plan)*: En la PAC se fijan objetivos institucionales anuales.
2. *Hacer (Do)*: Ejecución de las actividades pedagógicas y convivenciales cotidianas.
3. *Verificar (Check)*: Análisis semestral y anual de indicadores cuantitativos y cualitativos.
4. *Actuar (Act)*: Redacción de la Memoria Anual y diseño inmediato de un Plan de Mejoras con acciones correctoras para el siguiente ejercicio.

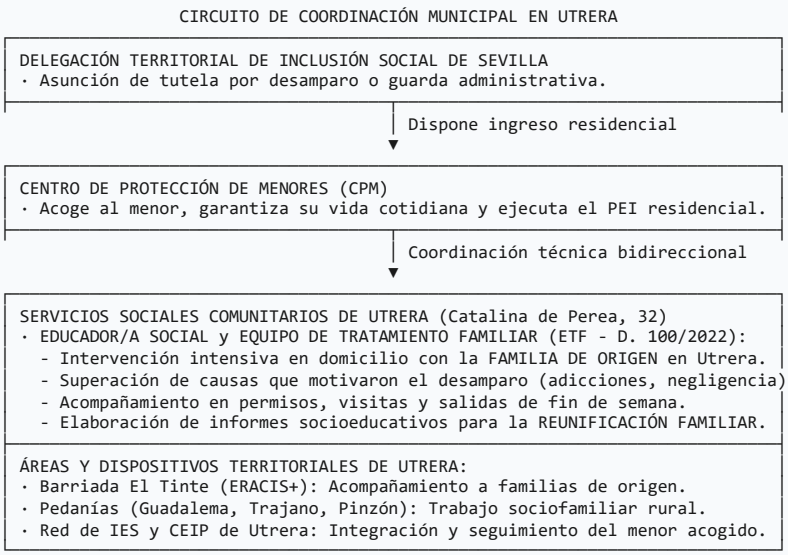
---

8. El/La Educador/a Social y Enfoque Práctico en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

8.1. El Rol de Articulación del Educador/a Social Municipal

En el organigrama del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el/la Técnico/a Medio de Educación Social (A2) desempeña sus funciones desde el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)**, ubicado en la **calle Catalina de Perea, nº 32**:

- Aunque la competencia exclusiva de tutela y guarda sobre centros residenciales corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía (a través de la Dirección General de Infancia y la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla), el/la Educador/a Social de la Administración Local es la **pieza angular para que el acogimiento residencial sea verdaderamente temporal, reversible y exitoso**.



8.2. Actuaciones de Coordinación en Utrera

1. Trabajo con la Familia de Origen para la Reunificación Familiar:

- Mientras el menor reside en el centro de protección, el Educador/a Social municipal y el **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF, Decreto 100/2022)** desarrollan un **Proyecto de Tratamiento Familiar (PTF)** en domicilio con los progenitores en Utrera, entrenando pautas de crianza, higiene doméstica, gestión económica y resolución no violenta de conflictos para erradicar las causas del desamparo.

2. Coordinación Escolar en Utrera:

- Menores en acogimiento residencial escolarizados en centros del término municipal (**CEIP Rodrigo Caro, Álvarez Quintero, Coca de la Piñera... e IES Ruiz Gijón, Ponce de León, Virgen de Consolación**): coordinación directa entre la tutoría escolar, el educador tutor del centro de protección y el Educador Social del **Equipo Municipal de Absentismo (EMAE)** para supervisar asistencia, rendimiento y adaptación social.

3. Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (ERACIS+):

- Apoyo socioeducativo intensivo a familias en extrema vulnerabilidad y con presencia de población gitana, facilitando recursos de inserción laboral y apoyo parental para evitar la cronificación del internamiento o propiciar un entorno seguro para el retorno.

4. Atención en Pedanías Rurales (Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón):

- Apoyo itinerante a unidades familiares dispersas cuyos hijos están acogidos temporalmente en centros residenciales, asegurando medios para los desplazamientos a visitas tuteladas y trámites técnicos.

---

9. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. 25 Datos de Examen (Memorización Directa para Tribunal)

1. **Art. 21 bis LO 1/1996**: El acogimiento residencial tiene carácter **subsidiario y excepcional** respecto al familiar.

2. Límite de 3 años: Prohibición de acordar acogimiento residencial para menores de 3 años salvo grave imposibilidad o razones de salud.

3. Preferencia hasta los 6 años: Prioridad legal imperativa del acogimiento familiar sobre el residencial para menores de 6 años.

4. Art. 22 ter LO 1/1996: Obligación de ofrecer programas de preparación para la vida independiente a partir de los **16 años**.

5. Decreto 355/2003 de Andalucía: Regula la estructura y funcionamiento del acogimiento residencial en centros de menores en Andalucía.

6. Orden de 11 de febrero de 2004: Fija los requisitos materiales, funcionales y ratios de personal en los centros de menores andaluces.

7. Plazo de elaboración del PEI: Debe confeccionarse en un plazo máximo de **30 a 45 días** desde el ingreso del menor.

8. Revisión del PEI: Periodicidad obligatoria de revisión técnica **semestral (cada 6 meses)**.

9. Libro de Vida: Técnica terapéutica de integración biográfica y narrativa de identidad acuñada por **Vera Fahlberg (1991)**.

10. LOPIVI (LO 8/2021): Obligatoriedad de designar la figura del **Coordinador/a de Protección** en centros residenciales.

11. Modelo de Calidad de Vida: Desarrollado por **Robert Schalock y Miguel Ángel Verdugo (2002)**, estructurado en **8 dimensiones**.

12. Modelo de Evaluación Tripartito: Formulado por **Avedis Donabedian (1980)**: Estructura, Proceso y Resultados.

13. Estándares de Calidad en Acogimiento: Investigaciones de referencia en España por **Amaia Bravo y Jorge F. Del Valle (2009)**.

14. Instituciones Totales: Concepto crítico acuñado por **Erving Goffman (1961)** para advertir contra los riesgos de la institucionalización masiva.

15. Vida Cotidiana como Herramienta: Fundamentada en pedagogía social por **Jaume Funes (1996)** y **Antoni Petrus (1997)**.

16. Apego Secundario Reparador: Teorizado por **Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan (2005)** en la relación con educadores de referencia.

17. Asamblea de Centro: Órgano de deliberación y participación comunitaria celebrado con periodicidad **semanal**.

18. Art. 12 de la CDN y Art. 9 LOPJM: Derecho imperativo del menor a ser escuchado en todo procedimiento administrativo que le afecte.

19. Batería SENA: Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes (**Fernández-Pinto et al., 2015**).

20. Escala CIES de Moos: Escala para evaluar el Clima Social en Instituciones Residenciales.

21. Dirección de Servicios Sociales en Utrera: Centro de Servicios Sociales Comunitarios en **calle Catalina de Perea, nº 32**.

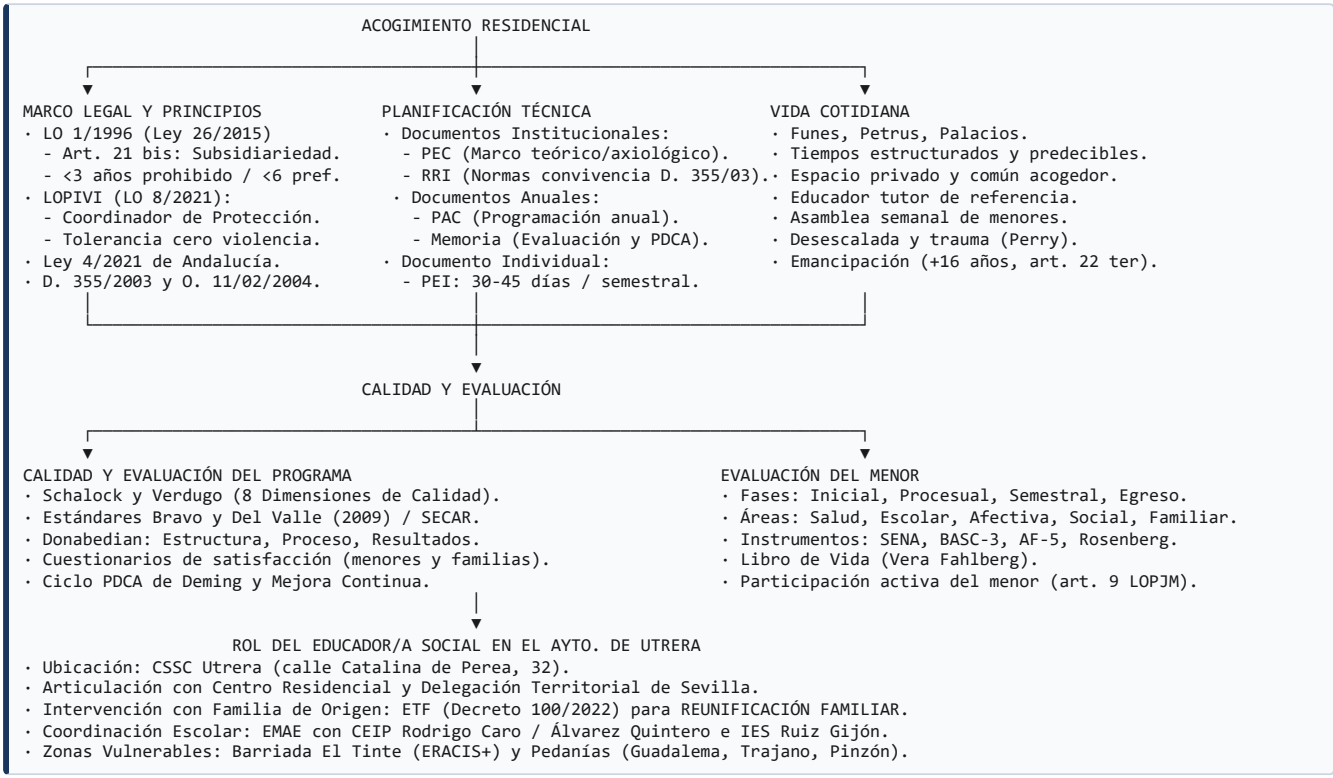
22. Equipo de Tratamiento Familiar (ETF): Regulado por el **Decreto 100/2022 de Andalucía**, clave en la reunificación familiar en Utrera.

23. Programa ERACIS+ en Utrera: Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, focalizada en la **Barriada El Tinte**.

24. EMAE Utrera: Equipo Municipal de Absentismo Escolar, coordinador entre centros de acogida y centros educativos ordinarios.

25. Pedanías de Utrera integradas: **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, destinatarias del seguimiento domiciliario del CSSC.

B. Esquema Sinóptico de Repaso Rápido



C. 7 Trampas Clásicas del Test Desarticuladas

1. Trampa: *El acogimiento residencial y el familiar se consideran opciones equivalentes que el técnico puede elegir libremente según disponibilidad de plazas.*

- **Desarticulación**: Falso. El artículo 21 bis de la LOPJM y la Ley 4/2021 consagran con fuerza imperativa el **principio de subsidiariedad y excepcionalidad**: el acogimiento residencial es el último recurso y solo procede cuando el familiar es inviable o contrario al interés del menor.

2. Trampa: *En caso de desamparo sobrevenido de un bebé de 18 meses, la entidad pública puede acordar su ingreso directo en un centro de protección ordinario por tiempo indefinido.*

- **Desarticulación**: Falso. La LOPJM **prohíbe el acogimiento residencial para menores de 3 años**, salvo imposibilidad insuperable acreditada o motivos graves de salud, debiendo acordarse siempre acogimiento familiar.

3. Trampa: *El Proyecto Educativo Individualizado (PEI) debe ser elaborado en los primeros 6 meses de estancia del menor en el centro.*

- **Desarticulación**: Falso. El PEI se elabora en la fase de acogida inicial, dentro de los **primeros 30 a 45 días** posteriores al ingreso. El plazo de 6 meses es para su **revisión semestral preceptiva**.

4. Trampa: *La Ley 26/2015 establece que los programas de preparación para la vida independiente comienzan a partir de los 18 años, coincidiendo con la mayoría de edad.*

- **Desarticulación**: Falso. El artículo 22 ter de la LOPJM y la Ley 4/2021 imponen que los programas de preparación para la vida independiente deben comenzar **a partir de los 16 años**.

5. Trampa: *La figura del Coordinador de Protección y Bienestar en centros residenciales de menores es una recomendación optativa de las directrices europeas sin carácter vinculante.*

- **Desarticulación**: Falso. Es una **obligación legal estricta e imperativa** establecida por la **Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI)**.

6. Trampa: *El modelo de calidad de Schalock y Verdugo evalúa exclusivamente la calidad de los recursos materiales e infraestructuras físicas del centro.*

- **Desarticulación**: Falso. Evalúa la **calidad de vida a través de 8 dimensiones multidimensionales** centradas en la persona (bienestar emocional, relaciones interpersonales, autodeterminación, etc.).

7. Trampa: *Al estar un menor ingresado en un centro de protección residencial dependiente de la Junta, los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera se desentienden del caso al extinguirse su competencia.*

- **Desarticulación**: Falso. Los Servicios Sociales de Utrera y el **ETF (Decreto 100/2022)** mantienen el papel nuclear de **intervenir intensivamente con la familia de origen residente en Utrera** para superar las causas del desamparo y hacer posible la reunificación familiar.

D. Supuesto Práctico Modal en el Ayuntamiento de Utrera

Planteamiento del Caso

El Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial en Sevilla decreta el desamparo urgente y el ingreso en un **Centro de Protección de Menores (CPM)** de acogida residencial de dos hermanos: **Marcos (14 años)** y **Lucía (9 años)**. El motivo es una situación de negligencia grave, consumo severo de tóxicos por parte de la progenitora en el domicilio familiar sito en la **Barriada El Tinte de Utrera** y absentismo escolar crónico no justificado superior al 60% en el **CEIP Álvarez Quintero** y el **IES Ruiz Gijón**.

El centro residencial de protección solicita la intervención activa y la coordinación técnica del **Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Utrera** (calle Catalina de Perea, 32). Marcos manifiesta conductas oposicionistas, aislamiento relacional y amenaza con fugarse del centro, mientras que Lucía presenta mutismo selectivo en clase y rechazo a hablar de su madre por miedo al castigo.

Intervención Técnica del Educador/a Social del Ayuntamiento de Utrera

```
                PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN TÉCNICA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FASE 1: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL INMEDIATA (Días 1 a 15)  │
│ · Contacto técnico con el Educador/a Tutor/a de referencia del CPM.
│ · Traspaso del informe social previo y antecedentes del expediente.
│ · Participación en la reunión técnica inicial para aportar datos al PEI.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 2: INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA DE ORIGEN EN UTRERA (Días 15 a 60)
│ · Activación del Equipo de Tratamiento Familiar (ETF - Decreto 100/2022).
│ · Formulación del Proyecto de Tratamiento Familiar (PTF) en el CSSC.
│ · Vinculación de la progenitora al Centro Comunitario de Adicciones (CTA)
│   y a los itinerarios sociolaborales del Programa ERACIS+ (El Tinte).
│ · Mediación y supervisión de los primeros contactos y visitas familiares.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 3: ARTICULACIÓN SOCIOEDUCATIVA DE LA VIDA COTIDIANA Y ÁMBITO ESCOLAR
│ · Coordinación con el IES Ruiz Gijón y CEIP Álvarez Quintero mediante el
│   Equipo Municipal de Absentismo (EMAE). Plan de refuerzo escolar.
│ · Marcos: Apoyo al educador del CPM en la elaboración de un Contrato de
│   Responsabilidad y tutorías para frenar el riesgo de fuga.
│ · Lucía: Elaboración del Libro de Vida guiado por su tutora del CPM.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 4: EVALUACIÓN SEMESTRAL Y PRONÓSTICO DE REUNIFICACIÓN
│ · Emisión del Informe Socioeducativo semestral coordinado CPM - CSSC.
│ · Valoración del cese del consumo de la madre y saneamiento del hogar.
│ · Si persisten mejoras: Propuesta formal a la Delegación Territorial para
│   el inicio de permisos progresivos de fin de semana y retorno familiar.
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. Fase de Diagnóstico Coordinado y Aportación al PEI (0 a 30 días):

- El/La Educador/a Social de Utrera mantiene reunión técnica bilateral con el educador tutor del centro residencial. Se trasladan los informes históricos de la familia, las dinámicas de la Barriada El Tinte y los antecedentes escolares. Se colabora activamente en la fijación de los objetivos del PEI para ambos menores.

2. Activación del Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) con la Progenitora:

- Conforme al **Decreto 100/2022**, el ETF de Utrera asume la intervención intensiva en el domicilio familiar. Se condiciona el progreso hacia la reunificación a la desintoxicación efectiva (seguimiento toxicológico con el Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones) y a la participación de la madre en talleres de competencias parentales en el CSSC de Catalina de Perea y en las actividades de inserción sociolaboral del plan **ERACIS+**.

3. Manejo de la Vida Cotidiana y Estructuración Escolar:

- En el IES Ruiz Gijón, se establece un plan de choque con el departamento de orientación y el **EMAE** de Utrera para Marcos: apoyo en aula de convivencia y vinculación extraescolar al Club Deportivo Utrera para canalizar su agresividad. En el centro residencial, su tutor trabaja acuerdos conductuales y le garantiza contacto telefónico regular con su abuela materna.

- Para Lucía, se inicia en el centro residencial la confección de su **Libro de Vida**, ayudándola a recopilar dibujos y fotos de Utrera y desculpabilizándola de la separación familiar, logrando remitir progresivamente el mutismo selectivo.

4. Evaluación Semestral y Plan de Retorno:

- A los seis meses, el Educador/a Social municipal del Ayuntamiento de Utrera y el equipo técnico del CPM emiten un informe conjunto: se constata la abstinencia de la madre, el saneamiento de la vivienda en El Tinte y la regularización de la asistencia escolar de los hermanos. Se propone a la Delegación Territorial de Sevilla la ampliación progresiva de salidas de fin de semana en Utrera bajo supervisión técnica del ETF, como fase previa a la reintegración familiar definitiva.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Consolidada

- **Barudy, J., & Dantagnan, M.** (2005). *Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y resiliencia*. Gedisa Editorial.
- **Bowlby, J.** (1988). *Una base segura: Aplicaciones clínicas de una teoría del apego*. Paidós.
- **Bravo, A., & Del Valle, J. F.** (2009). *Estándares de calidad en acogimiento residencial para la protección a la infancia*. Ministerio de Sanidad y Política Social.
- **Cyrulnik, B.** (2002). *Los patitos feos: La resiliencia y el trauma infantil*. Gedisa.
- **Donabedian, A.** (1980). *The Definition of Quality and Approaches to Its Assessment*. Health Administration Press.
- **Fahlberg, V.** (1991). *A Child's Journey Through Placement*. British Agencies for Adoption and Fostering (BAAF).
- **Funes, J.** (1996). *La nueva delincuencia infantil y juvenil*. Paidós.
- **Goffman, E.** (1961). *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. Anchor Books.
- **Junta de Andalucía**. (2003). *Decreto 355/2003, de 16 de diciembre, por el que se regula el acogimiento residencial de personas menores de edad*. BOJA nº 247, de 24 de diciembre de 2003.
- **Junta de Andalucía**. (2004). *Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se determinan los requisitos y condiciones técnicas y materiales que deben reunir los centros de protección de personas menores de edad*. BOJA nº 43, de 3 de marzo de 2004.
- **Junta de Andalucía**. (2021). *Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía*. BOJA nº 148, de 3 de agosto de 2021.
- **Junta de Andalucía**. (2022). *Decreto 100/2022, de 7 de junio, por el que se regula el Programa de Tratamiento Familiar para la atención a familias con menores en situación de riesgo o desprotección*. BOJA nº 111, de 13 de junio de 2022.
- **Palacios, J., & Amorós, P.** (Coords.). (2003). *Acogimiento residencial de menores: Modelos, evaluación y propuestas*. Alianza Editorial.
- **Petrus, A.** (Coord.). (1997). *Pedagogía Social*. Ariel Educación.
- **Schalock, R. L., & Verdugo, M. Á.** (2002). *Handbook on Quality of Life for Human Service Practitioners*. American Association on Mental Retardation.
- **SECAR (Sociedad Española para el Estudio del Acogimiento Residencial)**. (2009). *Criterios e indicadores de calidad en acogimiento residencial infantil*. Papeles del Psicólogo.